Le syndrome métabolique

TD destiné aux étudiants de 3ème année médecine

Dr Kaouache N

Objectifs

- Savoir diagnostiquer un syndrome métabolique

Introduction

Diabète FDR	Maladies cardiovasculaire
Obésité	• Obésité
Sédentarité	• Sédentarité
Age	• Age
Dyslipidémie	• Dyslipidémie
HTA	• HTA
…	…

La cooccurrence de facteurs de risque métabolique à la fois pour le diabète de type 2 et les MCV a fait suggéré l'existence d'un «syndrome métabolique»

Syndrome métabolique

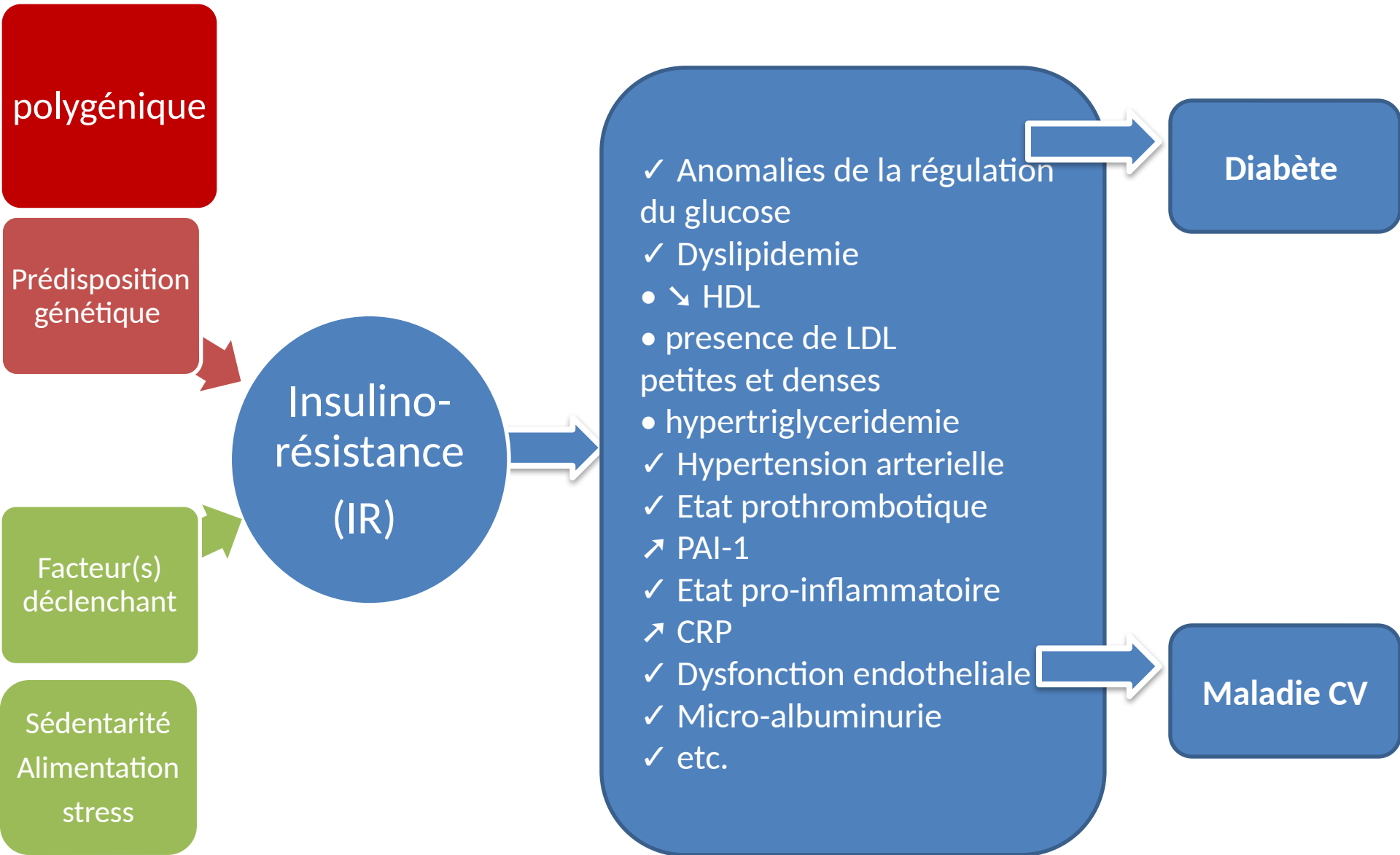
Définition :

Constellation d'anomalies **morphologiques** et **biochimiques** liées à une **insulino résistance** ,qui **évoluent en fonction du temps**, prédisposant le sujet atteint au diabète, à l'**athérosclérose** et à ses **complications**.

Appellations

- Syndrome de **Reaven**
- Syndrome **X**
- Syndrome **métabolique**
- Syndrome **dysmétabolique**
- Syndrome **plurimétabolique**
- Syndrome d'**insulinorésistance**

Physiopathologie



Signes du syndrome métaboliques

- **Signes cliniques**
- **Signes biologiques**

Anomalie du poids :l'obésité androïde

- Obésité à répartition abdominale



http://www.upml-lr.org/obesite-androide/

Matériel nécessaire pour le diagnostic

1. une toise .
2. pèse-personne gradué jusqu'à 150 kilos minimum et idéalement jusqu'à 200 kilos.

+

- La mesure du tour de taille doit être faite avec un mètre ruban.

Comment diagnostiquer le surpoids et l'obésité ?(IMC)

IMC:

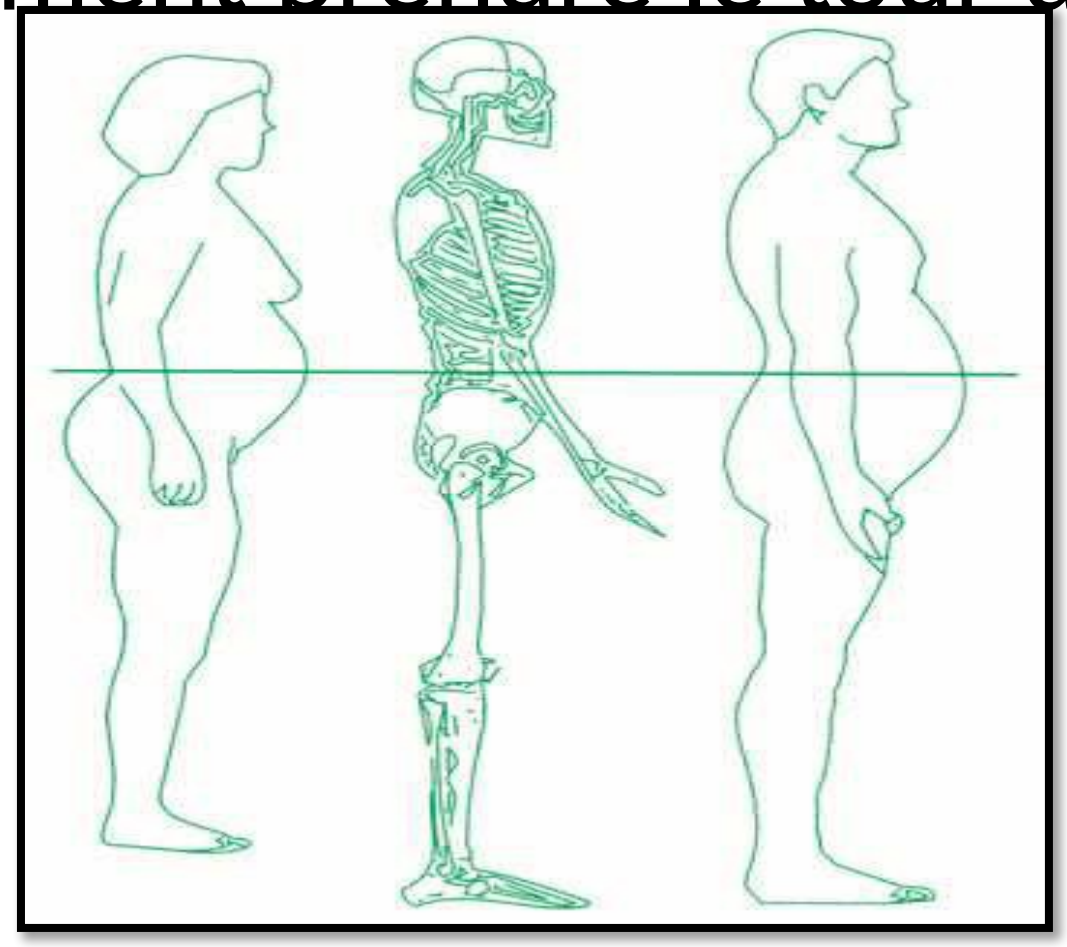
- Le diagnostic de surpoids et d'obésité repose sur l'indice de masse corporelle (IMC) calculé à partir du poids (en kilos) et de la taille (en mètres) (poids/taille au carré).

IMC = Poids (kg) / Taille^2 (m^2)

tour de taille

- Le tour de taille est un indicateur simple de l’excès de graisse abdominale (obésité abdominale)

Comment prendre le tour de taille



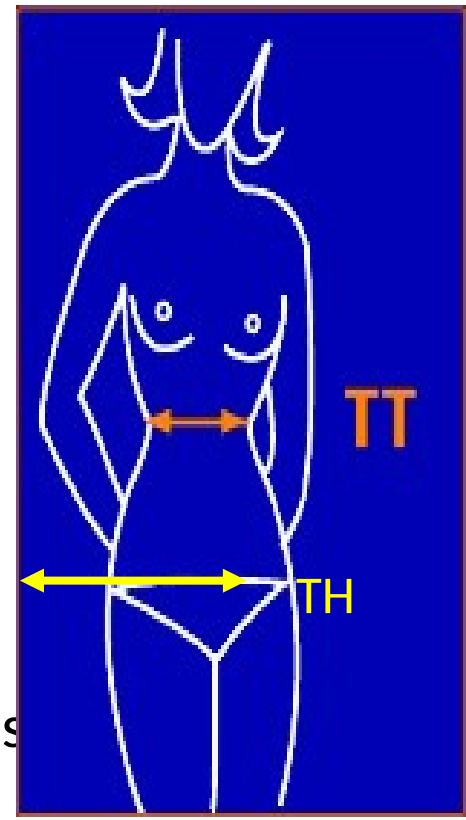
Mesure du tour de taille (à mi-distance entre le bord inférieur de la dernière côte palpable et le sommet de la crête iliaque, avec un mètre ruban placé à l'horizontale, à la fin d'une expiration

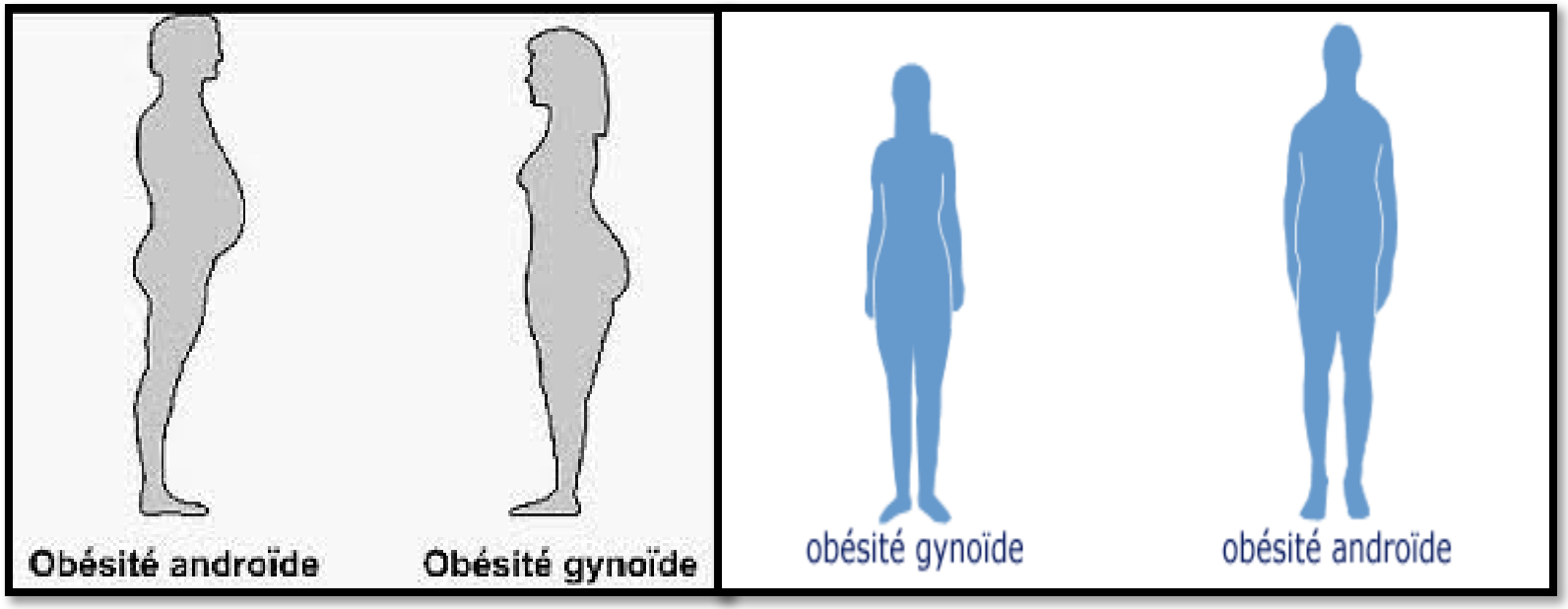
Formes cliniques

Rapport taille sur hanche (RTH)

- OBESITE GYNOÏDE RTH<0,8
  - Complications mécaniques

- OBESITE ANDROÏDE RTH>0,8
  - Complications métaboliques et cardiovasculaires
  - Chez l'homme TT > 102 cm
  - Chez la femme TT> 88 cm





https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=obesite-pm-symptomes-de-l-obesite

Anomalie de la glycémie: l'hyperglycémie

- **Glycémie** :taux du glucose dans le sang
- **Glycémie à jeun: glycémie** après au moins 8h du jeune
- **Glycémie post prandiale**: glycémie 2h après avoir commencé à manger
- **Glycémie à n'importe quel moment de la journée**
- **HbA1c** :le glucose lié à l'hémoglobine des globules rouge (équilibre des 8-12 semaines = durée de vie des GR (120J))

Anomalie de la glycémie

Normale :à jeun 0.7-1.00 g/l

pp <1.40g/l

HbA1c <5.7%

Pré-diabète

Hyperglycémie modérée à jeun GAJ:1.00-1.26g/l

Intolérance au hydrates de carbone GPP sup 1.40-2g/l

HbA1c:5.7 -6.4%

Diabète :

glycémie à jeun sup ou égale à 1.26g/l

Glycémie poste prandiale sup à 2g/l

HbA1c:>6.5%

Anomalie des lipides :la dyslipidémie

- Le bilan lipidique doit être demandé après un jeun de 12h= lipidogramme
- **Lipidogramme comporte** :

- ❑ Cholestérol total
- ❑ Triglycérides
- ❑ HDL cholestérol
- ❑ LDL cholestérol

Le syndrome métabolique :

- HDL bas
- TG élevés

Anomalie de la tension artérielle : hypertension artérielle (HTA)

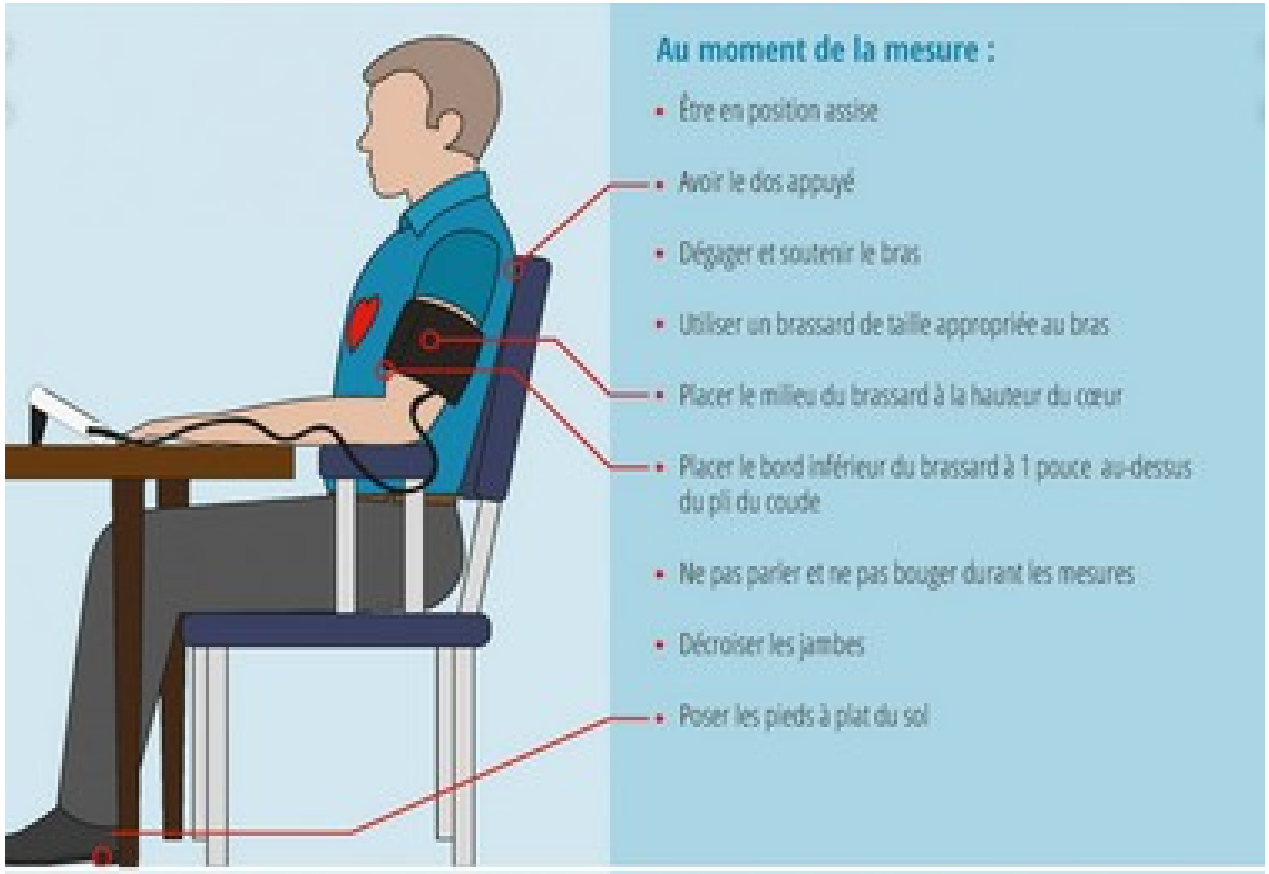
Conditions de mesure :

Avant de mesurer

- Avant de manger ou 2h après
- Après 5 min de repos
- Ne pas consommer le tabac, le café ou le chocolat dans l'heure avant la mesure
- Ne pas faire d'exercice dans les 30 min avant la mesure

Au moment de la mesure

- Etre en position assisse
- Avoir le dos appuyer
- Placer le milieu du brassard à la hauteur du cœur
- Placer le bord inferieur du brassard à 1 pouce au dessus du pli du coude
- Décroiser les jambes
- Placer les pieds à plat du sol


Au moment de la mesure :
Être en position assise
Avoir le dos appuyé
Dégager et soutenir le bras
Utiliser un brassard de taille appropriée au bras
Placer le milieu du brassard à la hauteur du cœur
Placer le bord inférieur du brassard à 1 pouce au-dessus du pli du coude
Ne pas parler et ne pas bouger durant les mesures
Décroiser les jambes
Poser les pieds à plat du sol

- **TA normale**: TAS <12/ TAD <08
- **TA normale haute**: TAS 12-14/TAD 08-09
- **Hypertension artérielle**: TAS > 139 et ou TAD >89

Autres anomalies :

- ✓ Augmentation de l’acide urique
- ✓ Augmentation de l’excrétion rénale d’albumine
- ✓ Acanthosis nigricans





Critères diagnostic
au moins 3 critères parmi les suivants

1. Obésité centrale (définie comme le tour de taille ⩾102 chez l'homme et ⩾88 cm chez la femme)
2. triglycérides ≥ 150 mg / dL (1,7 mmol / L)
   ou un traitement spécifique pour cette anomalie lipidique
3. HDL cholestérol bas
   <40 mg / dL (1,03 mmol / L) chez les hommes
   <50 mg / dL (1,29 mmol / L) chez les femmes
   ou un traitement spécifique pour cette anomalie lipidique
4. TA systolique ≥ 130 ou TA diastolique ≥ 85 mm Hg
   ou traitement de l'hypertension préalablement diagnostiquée
5. Glycémie à jeun ≥ 100 mg / dL (5,6 mmol / L),
   ou diabète de type 2 précédemment diagnostiqué

Prévention

- Le diagnostic du syndrome métabolique est important car il permet de savoir que la personne est à risque de faire le diabète et les maladies cardiovasculaires
- **Il va permettre de commencer la prévention :**

✓ Alimentation saine

✓ Activité physique

✓ Hygiène de vie